NARZĘDZIE 4 / 5

4-Etapowy Planer Kliniczny

Diagnoza → Cele → Mechanika → Kontrola. Formularz planowania do ręcznego wypełniania dla każdego przypadku.

PRZED ROZPOCZĘCIEM

Jak używać planera?

Wydrukować formularz dla każdego nowego przypadku; przechowywać w dokumentacji pacjenta.

Plan wynika z listy problemów. Najpierw diagnoza, potem cel, na końcu mechanika. Zmiana kolejności wydłuża leczenie.

1. **Etap 1 · Diagnoza** — Wypełnić dane dotyczące twarzy, okluzji, analizy miejsca, cefalometrii i pantomogramu. Do pantomogramu użyć Narzędzia 1, do klasyfikacji Narzędzia 3. Po zakończeniu wypisać listę problemów według ważności.

2. **Etap 2 · Cele** — Dla każdego problemu określić cel: twarz, wykończenie w relacji molarnej i kaninowej, overjet, overbite, linia pośrodkowa. Decyzję o ekstrakcji podjąć za pomocą Narzędzia 2; określić zapotrzebowanie na zakotwienie.

3. **Etap 3 · Kolejność mechaniki** — Zapisać kolejność osiągania celów. Dla każdego etapu określić łuk lub aparat pomocniczy. Odznaczać wykonane kroki.

4. **Etap 4 · Kontrola i wykończenie** — Pantomogram kontrolny, repozycja zamków, 6 kluczy okluzji i plan retencji. Przed zdjęciem aparatu każdy wiersz musi być odznaczony.

Zasada

Pusty wiersz to decyzja, która nie została podjęta. Przed naklejeniem zamków Etap 1 i 2 muszą być kompletne; następnie wykonać kontrolę końcową za pomocą Narzędzia 5.

Częsty błąd

Wpisywanie mechaniki z przyzwyczajenia. Najpierw korekta poprzeczna i ortopedyczna, potem niwelacja; nie przechodzić do korekty strzałkowej bez otwarcia zgryzu głębokiego.

Pola

Zaznaczyć odpowiednią opcję; jeśli nie ma jej na liście, dopisać na końcu wiersza.

Rewizja

Jeśli plan ulegnie zmianie, przekreślić stary wiersz, obok wpisać datę i nową decyzję.

PLANER · STRONA 1

Etap 1 • Diagnoza

Nie przechodzić do Etapu 2 przed skompletowaniem dokumentacji.

Pacjent / wiek / data

Powód zgłoszenia

Nawyk ☐ Ssanie palca ☐ Oddychanie ustami ☐ Wypychanie języka ☐ Bruksizm

Twarz

Profil ☐ Prosty ☐ Wypukły ☐ Wklęsły

Wargi ☐ Spokojne ☐ Napięte ☐ Protruzyjne ☐ Retruzyjne

Linia pośrodkowa twarzy / bródka

Uśmiech ☐ Nadmiar dziąsła ☐ Szerokie korytarze policzkowe ☐ Normalny

Okluzja

Molar / kanin (prawa · lewa)

Overjet / overbite (mm)

Linia pośrodkowa górna / dolna (mm)

Zgryz krzyżowy / przewieszony

Krzywa Spee ☐ Płaska ☐ Średnia ☐ Głęboka

Przesunięcie czynnościowe (CR–CO) ☐ Brak ☐ Jest: ____ mm

SSŻ ☐ Bez objawów ☐ Trzaski ☐ Ból ☐ Ograniczone otwieranie

Miejsce, cefalometria i dokumentacja

Zapotrzebowanie na miejsce góra / dół (mm)

Bolton ☐ Zgodny ☐ Nadmiar góra ☐ Nadmiar dół

SNA / SNB / ANB · Wits

FMA / SN-GoMe · IMPA / U1-SN

Pantomogram (Narzędzie 1) ☐ Czysty ☐ Są zmiany →

Przyzębie / biotyp ☐ Gruby ☐ Cienki ☐ Recesje

Faza wzrostu ☐ Przed skokiem ☐ W trakcie ☐ Zakończony

Diagnoza różnicowa (Narzędzie 3) ☐ Zębowa ☐ Szkieletowa ☐ Pseudo

Lista problemów (według ważności)

PLANER · STRONA 2

Etap 2 · Cele

Cel dla każdego problemu. Cel musi być mierzalny.

Cel twarzowy	☐ Zachować profil ☐ Zmniejszyć podparcie warg ☐ Zwiększyć podparcie warg
Wykończenie molarów prawa / lewa	☐ Klasa I ☐ Pełna klasa II ☐ Pełna klasa III
Wykończenie kanin	☐ Klasa I
Cel overjet / overbite (mm)	
Linia pośrodkowa	☐ Skorygować ☐ Zaakceptować
Pozycja siekaczy	☐ Zachować ☐ Retrakcja ☐ Kontrolowana proklinacja
Transwersalnie	☐ Niepotrzebne ☐ RME ☐ Ekspansja zębodołowa
Wertykalnie	☐ Zachować ☐ Otwarcie zgryzu głębokiego ☐ Zamknięcie zgryzu otwartego
Decyzja o ekstrakcji (Narzędzie 2)	☐ Bez ekstrakcji ☐ Ekstrakcja: _____
Zapotrzebowanie na zakotwienie	☐ Minimalne ☐ Średnie ☐ Maksymalne
Narzędzie zakotwienia	☐ TPB ☐ Nance ☐ Miniimplanty (TAD) ☐ Elastyki

Zaakceptowane granice / kompromisy	
Omówiono z pacjentem	☐ Opcje ☐ Czas trwania ☐ Retencja

PLANER · STRONA 3

Etap 3 · Kolejność mechaniki

Zapisać kolejność, odznaczać wykonane. Nie przechodzić do kolejnego kroku przed zakończeniem poprzedniego.

✓	KROK	ŁUK / APARAT / POMOCNICZE	DATA ROZPOCZĘCIA
☐	Ortopedia / ekspansja		
☐	Niwelacja i wyrównywanie		
☐	Zgryz głęboki / krzywa Spee		
☐	Zamykanie luk		
☐	Korekta strzałkowa		
☐	Linia pośrodkowa		
☐	Szczegółowe wykończenie (tork, rotacja)		

Etap 4 · Kontrola i wykończenie

Interwał kontroli

Pantomogram kontrolny (równoległość korzeni) ☐ Zaplanowano ☐ Wykonano

Repozycja zamków ☐ Niepotrzebna ☐ Zęby: _____

6 kluczy okluzji ☐ Molar ☐ Kąt korony ☐ Nachylenie korony ☐ Rotacja ☐ Kontakty ☐ Płaszczyzna okluzyjna

Overjet / overbite / linia pośrodkowa ☐ Osiągnięto cel

Retencja góra ☐ Stały lingwalny ☐ Hawley ☐ Essix

Retencja dół ☐ Stały lingwalny ☐ Hawley ☐ Essix

Ryzyko nawrotu / notatka

PRZYKŁAD

Wypełniony przykład

Przypadek fikcyjny. Wystarczy wypełnić własny przypadek z taką samą dokładnością.

1 · DIAGNOZA

Pacjent	*13 lat, dziewczynka. Powód: „Górne zęby są wysunięte."*
Twarz	*Profil wypukły, cofnięta bródka; wargi domykane z wysiłkiem*
Okluzja	*Molar i kanin obustronnie klasa II; overjet 8 mm, overbite 5 mm; głęboka krzywa Spee*
Miejsce / Bolton	*Zapotrzebowanie góra 2 mm, dół 3 mm; Bolton zgodny*
Cefalometria	*SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°, IMPA 97°*
Inne	*Pantomogram czysty; biotyp gruby; w fazie wzrostu; brak przesunięć*
Diagnoza (Narzędzie 3)	*Szkieletowa klasa II/1, retrogancja żuchwy; profil poprawia się w zgryzie konstrukcyjnym*
Lista problemów	*1) Strzałkowy (overjet) 2) Zgryz głęboki 3) Lekkie stłoczenie 4) Niewydolność warg*

2 · CELE

Twarz / strzałkowo	*Wyprowadzenie żuchwy do przodu; molar i kanin klasa I*
Overjet / overbite	*2–3 mm / 2–3 mm*
Ekstrakcja / zakotwienie	*Bez ekstrakcji (Narzędzie 2: siekacze dolne już proklinowane, do obserwacji); zakotwienie średnie*
Omówiono z pacjentem	*Współpraca przy aparacie czynnościowym, dwa etapy, czas retencji*

3 · KOLEJNOŚĆ MECHANIKI

1. Ortopedia	*Twin Block; regularna kontrola współpracy*
2. Niwelacja	*Przejście na aparat stały: sekwencja NiTi → stal*
3. Zgryz głęboki	*Korekta krzywej Spee, intruzja przednia*
4. Wykończenie	*Lekkie elastyki klasy II w razie potrzeby; tork i rotacja*

4 · KONTROLA I WYKOŃCZENIE

Kontrole	*Regularne; równoległość korzeni na pantomogramie kontrolnym*
Wykończenie	*Kontrola 6 kluczy; overjet i overbite w normie*
Retencja	*Góra Essix, dół stały lingwalny; ryzyko nawrotu: proklinacja siekaczy dolnych*

Materiał służy celom edukacyjnym. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

Następny krok

Jeśli formularz został wypełniony, przed naklejeniem zamków należy przeskanować plan za pomocą **Narzędzia 5 · Radar Błędów Planowania**. Pełna logika planowania znajduje się w **Module 03 Planowanie Kliniczne: od Listy Problemów do Mechaniki**.